

14 - 8 Gestion ds entretiens triangulaires

(0:01 - 0:32)

Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce cours faisant partie des situations de communication clinique spécifique qui est la gestion des entretiens triangulaires. L'influence sur la communication de la présence d'une troisième personne ou bien de la famille du malade dans nos consultations est très peu étudiée. Cependant, 20% des personnes de plus de 65 ans sont accompagnées quand elles rendent visite à leur médecin.

(0:33 - 1:02)

20% des patients ayant un cancer sont accompagnés indépendamment de leur âge ou de leur sexe. L'étude de la relation triangulaire et de l'entretien systémique est encore très peu développée en médecine. En effet, l'alliance avec le proche accompagnant peut se révéler particulièrement judicieuse pour le patient et pour le soignant et ce dans le cadre d'une prise en charge collective.

(1:03 - 1:25)

Le plus souvent, il est en effet un témoin privilégié de la vie quotidienne du patient et de ses modes d'adaptation face à la maladie. Une des premières variables à prendre en compte est le lien de parenté qui unit le malade à la personne qui l'accompagne. L'accompagnant sera le plus fréquemment le conjoint du patient.

(1:26 - 1:54)

Moins fréquemment et de manière équivalente, il s'agira d'un enfant, d'un parent ou d'un membre de la fratrie. Cet accompagnant est très souvent le preneur en charge primaire du patient, c'est-à-dire c'est celui qui s'en occupe le plus. La présence d'un proche en consultation est plus fréquente lorsque la situation médicale est difficile, maladie grave ou bien lors des premières consultations.

(1:58 - 2:28)

Le patient se tourne vers sa famille quand son état se dégrade pour trouver une aide psychologique et aussi matérielle. Cet accompagnement peut aussi servir la famille en diminuant sa propre anxiété et ses incertitudes face à la maladie de son proche. La faiblesse du patient, son opposition au traitement ou le déni de la maladie sont d'autres cas de figure possible dans lesquels les soignants sont amenés à rencontrer les proches.

(2:29 - 2:51)

Et l'épuisement émotionnel des proches est aussi une cause de leur présence dans les

entretiens. L'impact sur la communication. La présence d'une tierce personne introduit des modifications importantes dans l'interaction entre médecin et malade.

(2:52 - 3:32)

D'abord, quels sont les avantages d'être accompagné ? Cela a un effet de soutien et d'encouragement pour le patient. Cela l'aide à prendre des décisions, à verbaliser ses questions et ses inquiétudes. Permet au médecin de récolter des informations supplémentaires et aide le malade à se rappeler des paroles du médecin et à les interpréter. Cependant, quels sont les inconvénients d'être accompagné ? En fait, au lieu de soutenir le patient, l'accompagnant peut exprimer ses propres préoccupations et occulter celles du patient.

(3:33 - 3:59)

Il peut chercher à obtenir la certitude que les meilleurs soins sont prodigués ou que la bonne décision est prise. Ces différents objectifs peuvent amener le proche à dominer l'interaction pour aboutir à ses fins. Un deuxième inconvénient, c'est que cela empêche le patient d'exprimer ses craintes et parler librement et ouvertement de ses peurs pour ne pas perturber ses proches.

(4:00 - 4:27)

En outre, il ne peut pas communiquer sa perception de la situation, ses sentiments, à son propre rythme. Les conséquences lors des entretiens triangulaires sur la longueur de la consultation, sur les objectifs du soignant ainsi que sur les stratégies de communication. D'abord, augmenter la durée de consultation alors que le médecin a déjà un horaire très chargé.

(4:29 - 4:52)

Plonger les soignants et plus particulièrement les médecins dans un dilemme. D'un côté, leur devoir est centré sur les soins, sur le bien-être de leur patient. Et d'un autre côté, ils savent très bien que le contact avec la famille permet d'améliorer les conditions de vie du malade, d'encourager, de soutenir les efforts de la famille, de valoriser son aide pour le patient.

(4:53 - 5:23)

Donc les soignants sont tiraillés entre les intérêts des deux parties, patient et entourage. Cela influence bien évidemment les stratégies de communication utilisées par les soignants. Quand un proche est présent, certains patients pourraient ne pas aborder leurs inquiétudes pour leur famille ou bien des questions relatives à la sexualité ou à d'autres domaines d'ordre intime.

(5:29 - 5:42)

Quelles sont les recommandations au cas de présence d'un proche ? D'abord, faire connaissance. Identification de chaque personne présente. Clarification du rôle de chacun par

rapport au malade.

(5:42 - 5:56)

Et reconnaissance du rôle important joué par les proches. Deuxièmement, clarifier les attentes des proches. Clarifier la compréhension de chaque proche.

(5:57 - 6:28)

Et clarifier les préoccupations de chaque proche. Troisièmement, clarifier les attentes du patient. Ses préoccupations, les questions relatives à sa maladie, évaluation de ses priorités, par quelles questions, comment se tend, évaluer les questions que le patient souhaiterait clarifier en famille et celles qu'il souhaiterait clarifier seul avec son médecin.

(6:29 - 6:47)

Quatrièmement, proposer un agenda. C'est-à-dire clarifier le but de la consultation. Qu'est-ce que le médecin doit faire ? Il faut estimer aussi le temps nécessaire pour répondre aux questions et les préoccupations de chacun.

(6:49 - 7:11)

Et reconnaître si nécessaire la difficulté de répondre à toutes les questions. En conclusion, de nombreuses questions éthiques se posent aussi. C'est-à-dire, dans quel cas une rencontre avec la famille est-elle conseillée ? Quelle place les proches doivent-ils occuper dans le processus de soins ? Je vous remercie.